PATIENT SAFETY
(KESELAMATAN PASIEN)

dr. Riskiyah, MMRS
PSPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2026



KESELAMATAN PASIEN





PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 11/MENKES/2017 TENTANG KESELAMATAN PASIEN



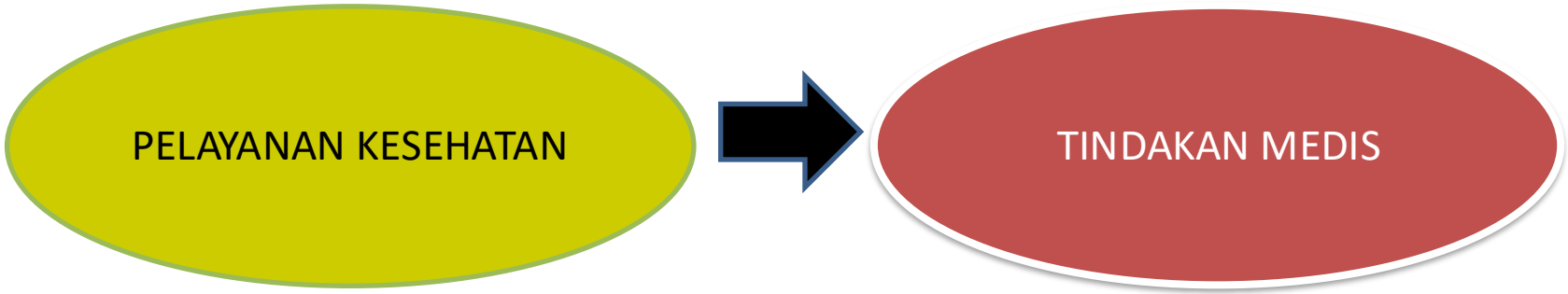
"I'M AFRAID THERE WERE COMPLICATIONS."

TANTANGAN DUNIA DALAM KESELAMATAN PASIEN



Kenapa sering Terjadi Kesalahan/ *Medical Error* di Rumah Sakit????





- Hampir setiap tindakan medis menyimpan potensi risiko
- Dalam kenyataan masalah medical error → mencerminkan fenomena gunung es → terdeteksi umumnya adalah adverse event yang ditemukan secara kebetulan saja
- Sebagian besar yang lain cenderung tidak dilaporkan, tidak dicatat, atau justru luput dari perhatian

In the Hospital



Because there are hundreds of medications, tests and procedures, and many patients and clinical staff members in a hospital, it is quite easy for a mistake to be made. Such mistakes can include giving someone the wrong medication, performing the wrong tests (such as lab tests or X-rays), performing the wrong procedures, or neglecting to do any of the above when they have been ordered by a doctor.

- Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur
- Banyaknya jumlah pasien maupun staf RS

Potensial terjadinya kesalahan medis

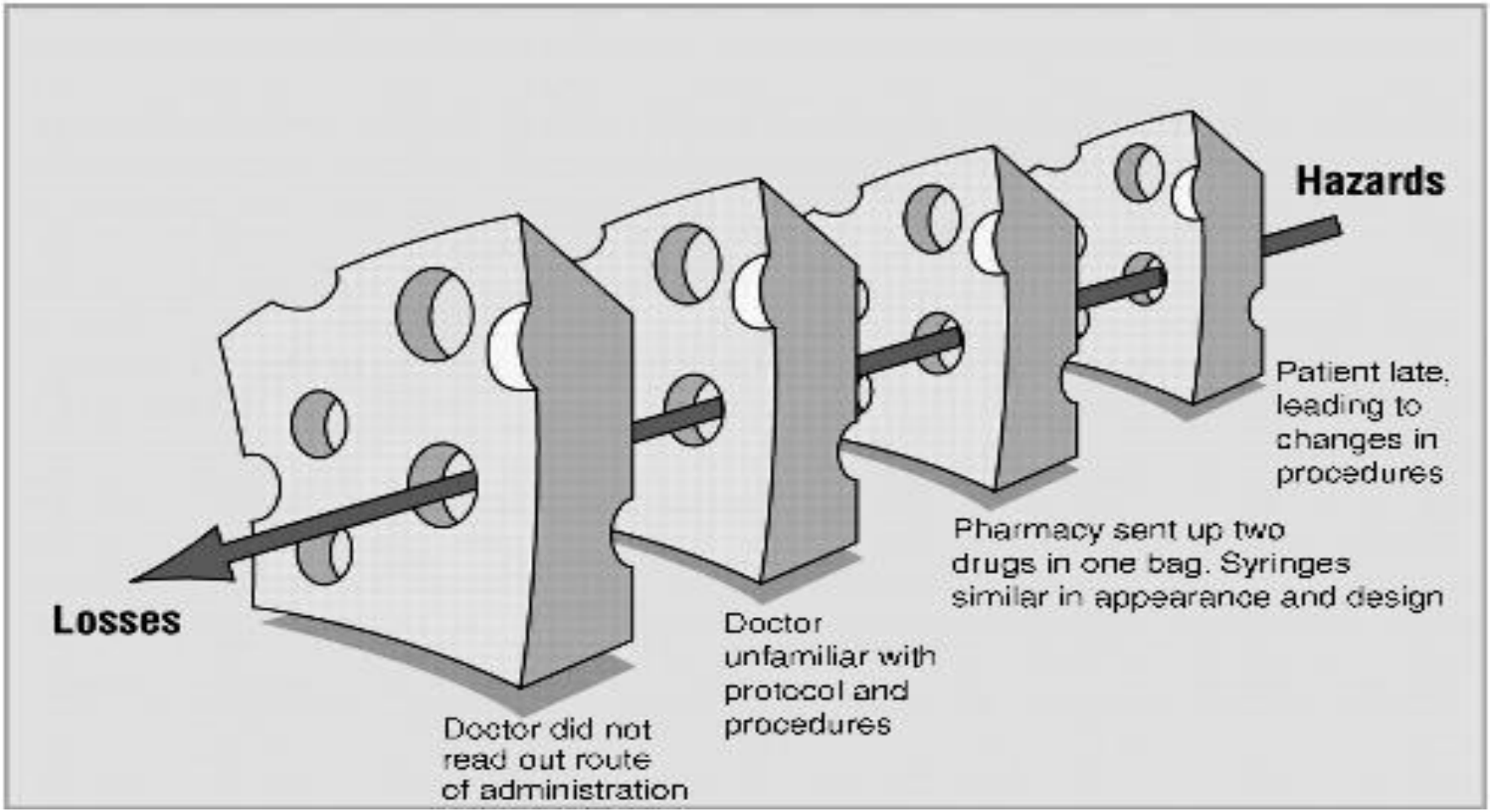
KESALAHAN MEDIS YANG SERING TERJADI

1. Kesalahan obat → Cara memberikan obat yang salah/memberikan obat yang salah/salah orang
2. Kesalahan identifikasi pasien
3. Kesalahan prosedur saat operasi/tindakan keperawatan/tindakan medis yang didelegasikan
4. Pencatatan tindakan pembedahan
5. Melaksanakan praktek tidak kompeten
6. Pasien jatuh

Kesalahan Medis/Medical Error

- Tindakan medis yang menyebabkan timbulnya adverse events
- Medical error dapat menyebabkan;
  - Cedera, kecacatan, kematian
  - Lama perawatan lebih lama (*prolonged hospitalization)*
  - Biaya perawatan lebih besar





Swiss Cheese: vulnerabilities in the system (after Reason, 1997).

Fakta tentang Patient Safety

Keselamatan pasien adalah isu kesehatan global yang sangat serius

Estimasi menunjukkan bahwa di negara maju sebanyak satu dari 10 pasien dirugikan saat menerima perawatan di rumah sakit

Di negara berkembang, kemungkinan pasien yang dirugikan di rumah sakit lebih tinggi daripada di negara-negara industri

Di beberapa negara proporsi suntikan diberikan dengan menggunakan jarum suntik tanpa sterilisasi setinggi 70%

pengalaman pasien dan kesehatan mereka berada pada gerakan keselamatan pasien

44,000-98,000 orang meninggal setiap tahun dari kesalahan medis



MENGAPA PATIENT SAFETY PENTING

PATIENT CENTEREDNESS

TIDAK BOLEH ADA PX MENDERITA AKIBAT CIDERA YANG DAPAT DICEGAH

MEDICAL ERROR→ MENINGKATKAN BIAYA ATAS KESEHATAN

TUNTUTAN MALPRAKTEK MENINGKAT

MENCEGAH KONFLIK (BLAMMING) ANTARA DOKTER/PETUGAS KESEHATAN/PX

Menjamin Keselamatan Px Tiap Hari

Meskipun Upaya Terbaik dari Penyedia Pelayanan kesehatan, Kesalahan muncul ketika Merawat Pasien



Definisi Patient Safety

- *"The avoidance, prevention and amelioration of adverse outcomes or injuries stemming from the process of healthcare"* (Vincent C. Patient Safety, 2nd edn. Oxford: Wiley Blackwell; 2010.)

- "Safety is a fundamental principle of patient care and a critical component of quality management"
- (World Alliance for Patient Safety, Forward Program WHO, 2004)



Keselamatan Pasien

- Suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman
- Meliputi:
  - asesmen risiko,
  - identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien,
  - pelaporan dan analisis insiden,
  - kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
  - serta implementasi solusi untuk:
    - meminimalkan risiko
    - mencegah terjadinya cedera oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Patient Safety Involves :

Meminimalkan kemungkinan kesalahan

Mengurangi kesalahan medis untuk meningkatkan px safety

Belajar dari kesalahan untuk meningkatkan px safety



INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Disebut Insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan/berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegaj pada pasien. Terdiri dari:

- KTD : adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien.
- KNC: adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien.
- KTC: adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera.
- KPC: adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden.
- Kejadian Sentinel: adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius.

WHAT DO WE MEAN BY “SAFE’’ ?

BEING SAFE MEANS



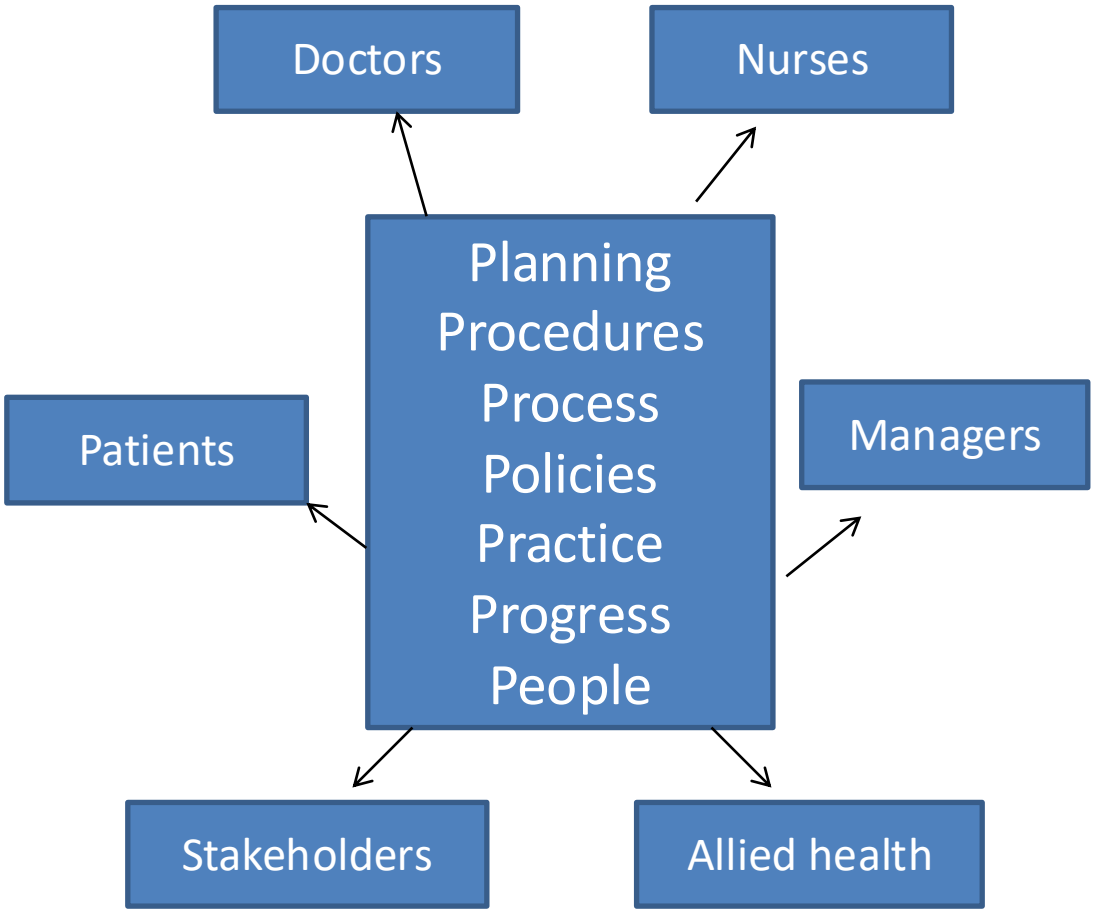
TUJUAN PATIENT SAFETY

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di RS
2. Meningkatnya akuntabilitas RS terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunnya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di RS
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD
5. Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasyankes

Implementation: Needs Collaborative Process



A collaborative process is used to develop policies and/or procedures that address each of the specific goals



PENYELENGGARAAN PX SAFETY

- Pembentukan Sistem Pelayanan yang menerapkan:

7 Standar Keselamatan Pasien

6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien)

7 Langkah menuju keselamatan pasien

7 Standar Keselamatan Pasien

1. Hak Pasien
2. Pendidikan bagi Pasien Dan Keluarga
3. Keselamatan Pasien Dalam Kesinambungan Pelayanan
4. Penggunaan Metode Peningkatan Kinerja Untuk Melakukan Evaluasi Dan Program Peningkatan Keselamatan Pasien



5 Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien

6 Pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien

7 Komunikasi Merupakan Kunci Bagi Staf Untuk Mencapai Keselamatan Pasien.



1. HAK PASIEN

- Hak pasien dan keluarga untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara, tujuan, alternatif, risikodan komplikasi tindakan medis

2. Pendidikan bagi Pasien dan Keluarga

- Kegiatan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien
- **Kriteria standar pendidikan:**

- Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur
- Mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya
- Mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti
- Memahami konsekuensi pelayanan
- Mematuhi nasihat dokter dan menghormati tata tertib Fasyankes
- Memperlihatkan sikap saling menghormati
- Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati

3. Keselamatan Pasien Dalam Kesinambungan Pelayanan

- Upaya fasyankes di bidang keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan
- Kriteria:

- Pelayanan secara menyeluruh dan terkoordinasi
- Koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ketersediaan sumber daya Fasyankes
- Koordinasi pelayanan dalam meningkatkan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, asuhan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi, rujukan dan tindak lanjut
- Komunikasi dan penyampaian informasi antar profesi kesehatan sehingga tercapai proses koordinasi yang efektif

4. Penggunaan Metode Peningkatan Kinerja Untuk Melakukan Evaluasi Dan Program Peningkatan Keselamatan Pasien

- Mendesain proses baru/memperbaiki proses yang telah ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien
- Setiap Fasyankes harus melakukan evaluasi semua insiden dan secara proaktif melakukan evaluasi 1 proses kasus risiko tinggi setiap tahun

5. Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien

- Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola keselamatan pasien
- Tersedia kegiatan atau program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden
- Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden
- Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden

6. Pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien

- Setiap Fasyankes harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik patient safety sesuai dengan tugasnya masing2
- Mengintegrasikan topik patient safety dalam setiap kegiatan pelatihan/magang dan memberikan pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden
- Menyelenggarakan pelatihan tentang teamwork

7. Komunikasi Merupakan Kunci Bagi Staf Untuk Mencapai Keselamatan Pasien

- Kegiatan Fasyankes dalam merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi Patient safety untuk memenuhi kebutuhan informal internal dan eksternal yang tepat waktu dan akurat
- Kriteria:

- Tersedia anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait patient safety
- Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada

6 Sasaran Keselamatan Pasien

1. Ketepatan identifikasi pasien
2. Peningkatan komunikasi yang efektif
3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai

4

- Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi

5

- Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

6

- Pengurangan risiko cedera pasien akibat terjatuh



• Use 2 patient identifiers –for example, name and identification number

•Do not us room numbers to identify patients

• Staff should ask the patient to state their name instead of asking ‘’Are you Mr. Budi?”

• ASKS :

‘’What is your name?” √

• Not :

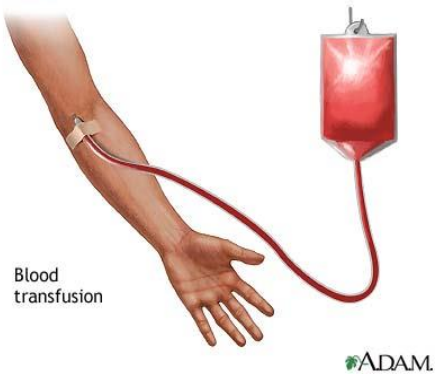
•“ Are you Mr. Budi?’’ X

RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA
RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA
RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA

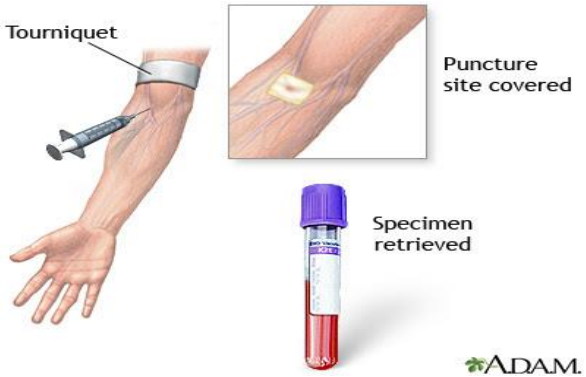

22/02/2015

Identify Patients Correctly

BEFORE.....



Blood transfusion



Specimen Taking



Treatment& procedures

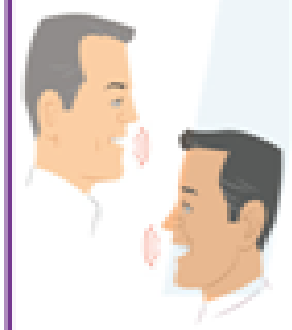


Surgery Interventions



Administer Medication

GOAL 2



Improve Effective Communication

Ketika menerima perintah lisan atau memberikan informasi klinis melalui telepon, pastikan bahwa urutan atau informasi dipahami dengan jelas

perintah lisan, termasuk melalui telepon, sering disalahartikan dan dapat menyebabkan bahaya pasien yang signifikan

Dalam penelitian terbaru, salah satu rumah sakit menemukan tingkat kesalahan 9% dengan perintah verbal.

They reduced this error rate to zero by implementing a read back protocol


REMEMBER

S= Menanyakan hasil FL + DL: [illegible]

B= hasil terlampir

A= GEA + Vomiting Acut + OF HIP

R= Ada acid terapi tambahan obat dokter obsi: 92

A/P ceftriin . 3x 300.000 IU

Pasien pindah (+)

KONFIRMASI	
Tgl : 22/8/17	Paraf :
Jam : 7.30	
DPJP : dr. [redacted] SpA	

Pasien dipindah permintaan

Dewi

(S-O-A-P)

KESEHATAN LAIN
(S-O-A-P / S-B-A-R)

S: diare (+) batuk (+)
pilek (+)

O: GCS 456
BCG (+) N

A: Of fls + GEA +
Vomiting akut +
(SOA)

Ptx:

Infus Kaen 3B 900 cc / 24 jam

12 tpm makro

iv ranitidin 2x10 mg

iv ondansetron 3x 2 mg
(k/p, bila muntah)

Po. zinkid syr 2x5 cc

Po. Lactob 2x1

Po. colistin 3x300.000 iu

Po. Sanmol drop 4x1 cc
(k/p, ≥ 37,5°C)

Po. puyer 3x1

Mo: VS; muntah

S= DAB cair ampas 4x sdikit ↓

O= Ku comp. suara hangat, panas (-)
Mual (-) muntah (-) bab pilek -/-
bab (+), bau (+) merah ↓. s.inguen 2-3
T: jentik B. N: 98^6 S: 35,9 RR: 20x

A= Kebutuhan sumbangan nutrisi kurang dari kebutuhan b.d. output berlebih

P= obs VS,
output input
Kolaborasi dengan dr. spA
Inf Kaen 3B. 900 cc/24 J. (12 tpm makro).
iv Ranitidin 2x10 mg
Ondansetron 3x 2 mg.
Santagesik 3x100 mg.
Po Zinc. Kids syr 2x5cc
Lacto B. 2x1
Sanmol drop 4x1 cc
Colistin 3x300.000 iu
E Fe. (+) hasil

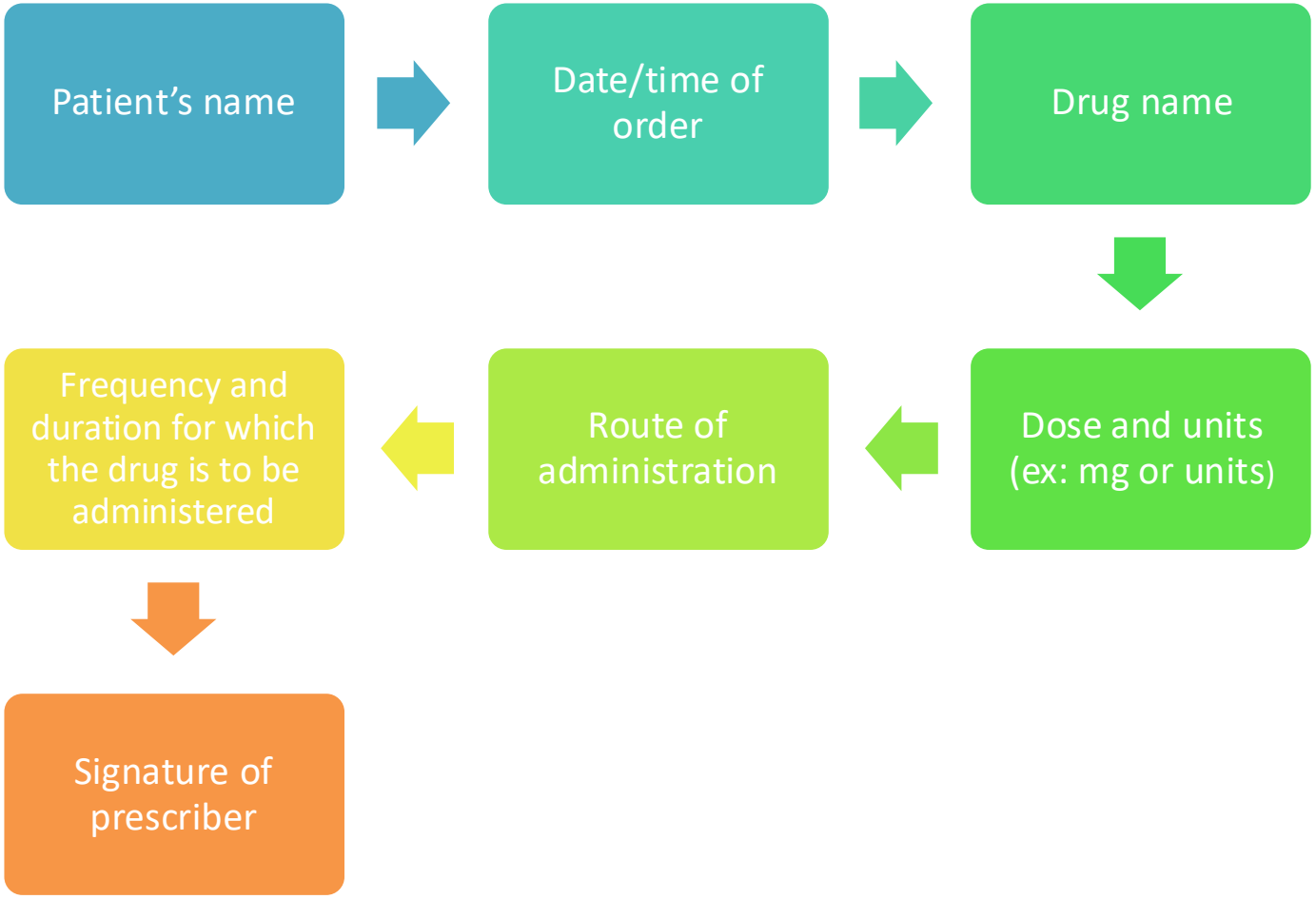
NOTASI
Tgl : 21/8/17
Jam : 15.00
Paraf :
DPJP : dr. [redacted] Sp.A

dr. [redacted] / UTTife
- tambahan puyer batuk 3x

dr. [redacted]

Improve Effective Communication

- A complete Medication Order includes:



High-Alert Medications



Medications that have a high risk of causing significant patient harm :

- Look-Alike
- Sound-Alike (L A S A)
- High Concentration Drugs

Look Alike-Confusing







Sound – Alike

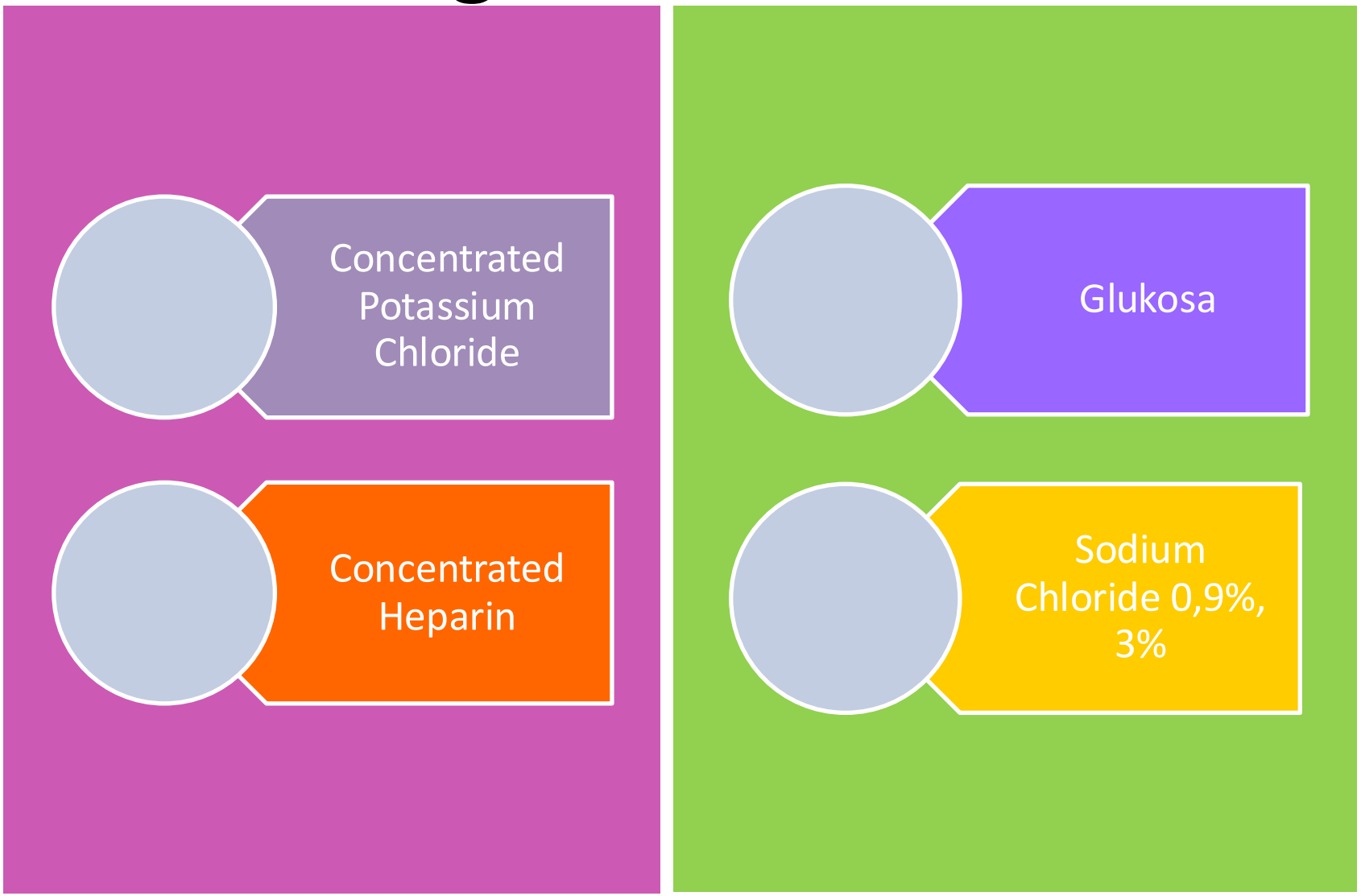
- Xanax (alprazolam)
- Losec (omeprazole)
- Daflon
- Zantac
- Dopamine

- **Zantac (Ranitidine)**
- **Lasix (furosemide)**
- **Dolfenal**
- **Zyrtec (Cetirizine)**
- **Dobutamine**





High Consentration



Reduce Risks

1. Identify them with high-risk labels
2. Segregate the look-alike and sound-alike drugs
3. Keep high-alert drugs secured/locked
4. Remove concentrated electrolytes (ex potassium chloride) from the wards
5. Keep minimal stock of high-alert drugs/high concentrated solutions



Labeling High-Risk Medications

Distinct Packaging

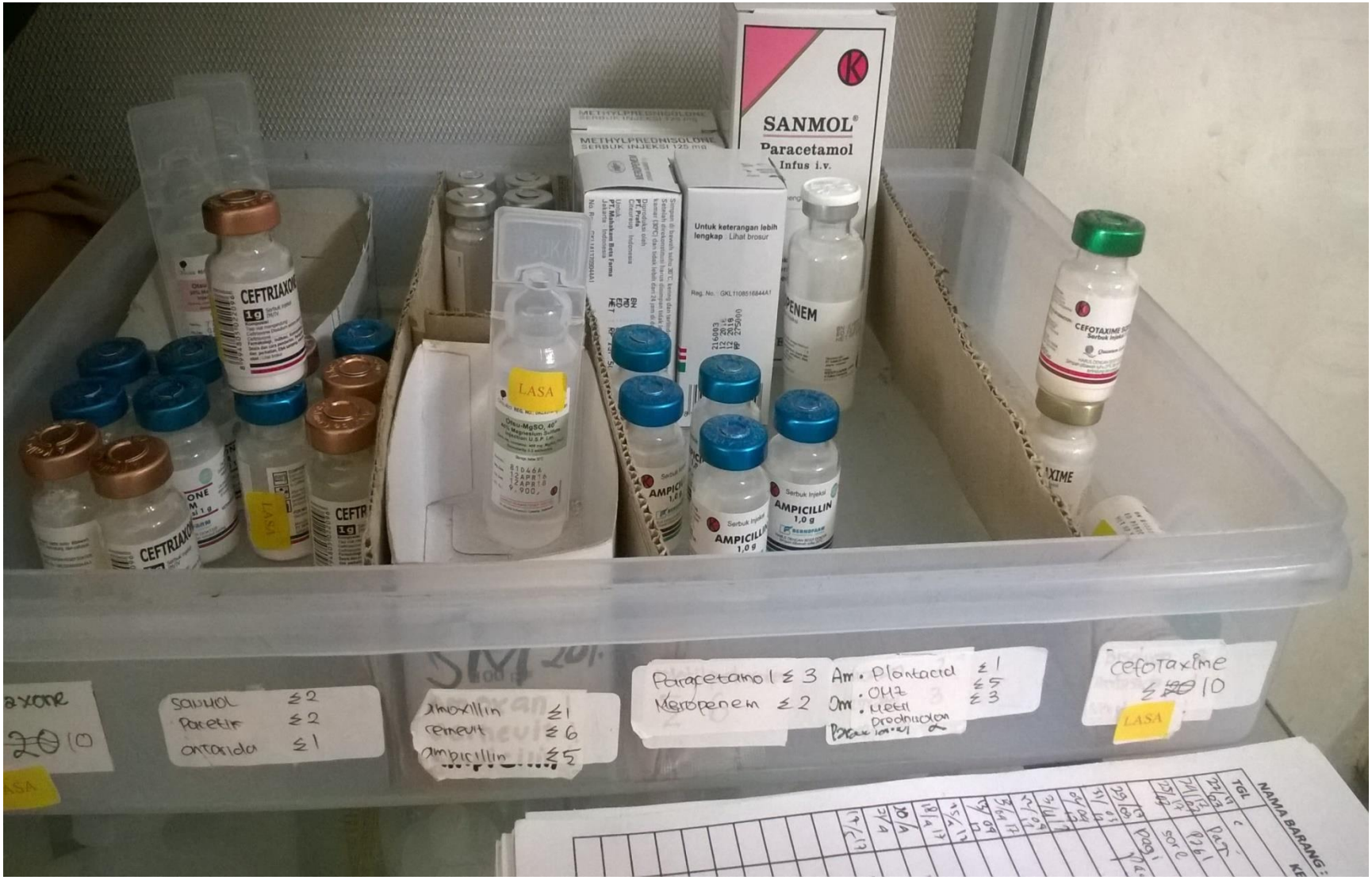
Harmful Effects

Prominent Warning

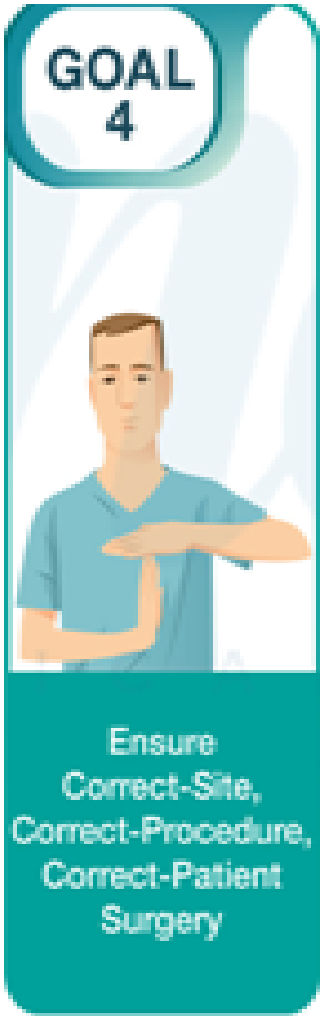
Indications



Peletakan Obat LASA



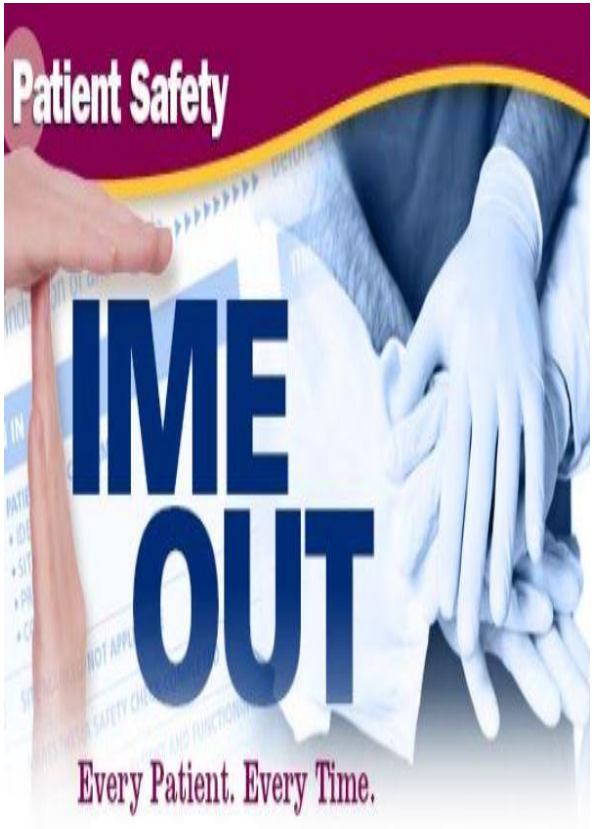

ALinamin F
BISOLVON
Aminophylline
Santagesik/ Antrain
EPEDRIN
Combivent
HIGH ALERT
Ca-Glukonas
Dipenhidramin
ETASON
Ranitidin
Tramadol
KETOROLAC
LASA
Nicholin
Neurosanbe
Furosemide
Proterin
Piralen
Plasminex
Pulmicort
Ondancentron
Gentamicin
Vitamin A
Vitamin C
Vit K
VENTOLIN
PACKAGE CONTENTS
Main unit, arm cuff,
instruction manual, 4 "AA"
storage case
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD.



1. Correct patient identity
2. Correct side and site
3. Agreement on the procedure to be done
4. Correct patient position
5. Availability of correct implants
6. And any special equipment

Time out → Before Start of Surgery

Surgical Timeout



- Melibatkan seluruh tim operasi
- Komunikasi aktif
- Mencocokkan perbedaan jawaban staf selama " time out’’

Surgical Site Marking

- Use Permanent ink
- Involves the patient in the marking process
- Use a standardized and clearly understood mark for surgical site identification



Causes of Surgical Errors

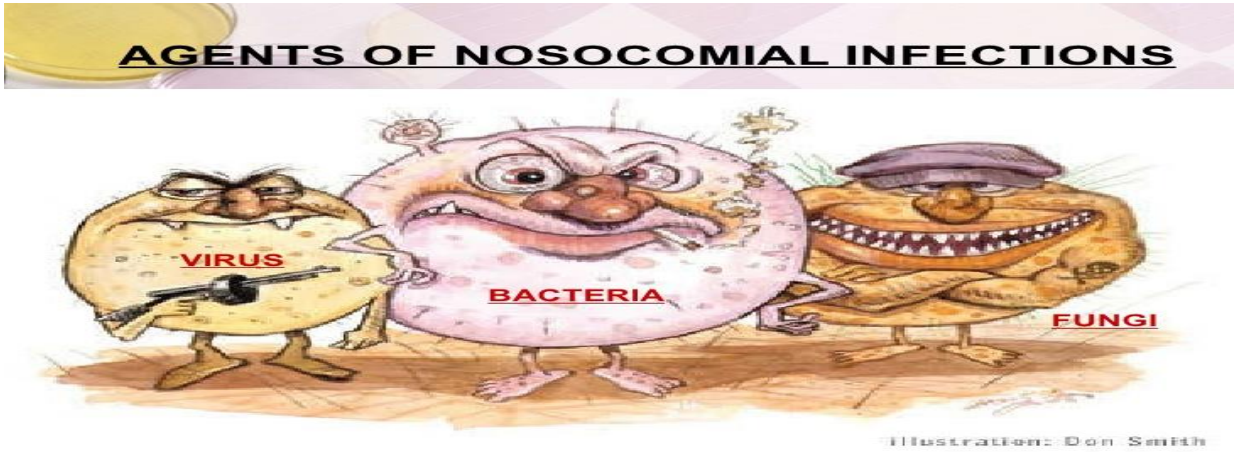
1. Komunikasi yang tidak efektif antara anggota tim bedah
2. Kurangnya kerja sama tim
3. Kurangnya melibatkan pasien dalam menandai lokasi
4. Kurangnya standar prosedur untuk memeriksa lokasi operasi



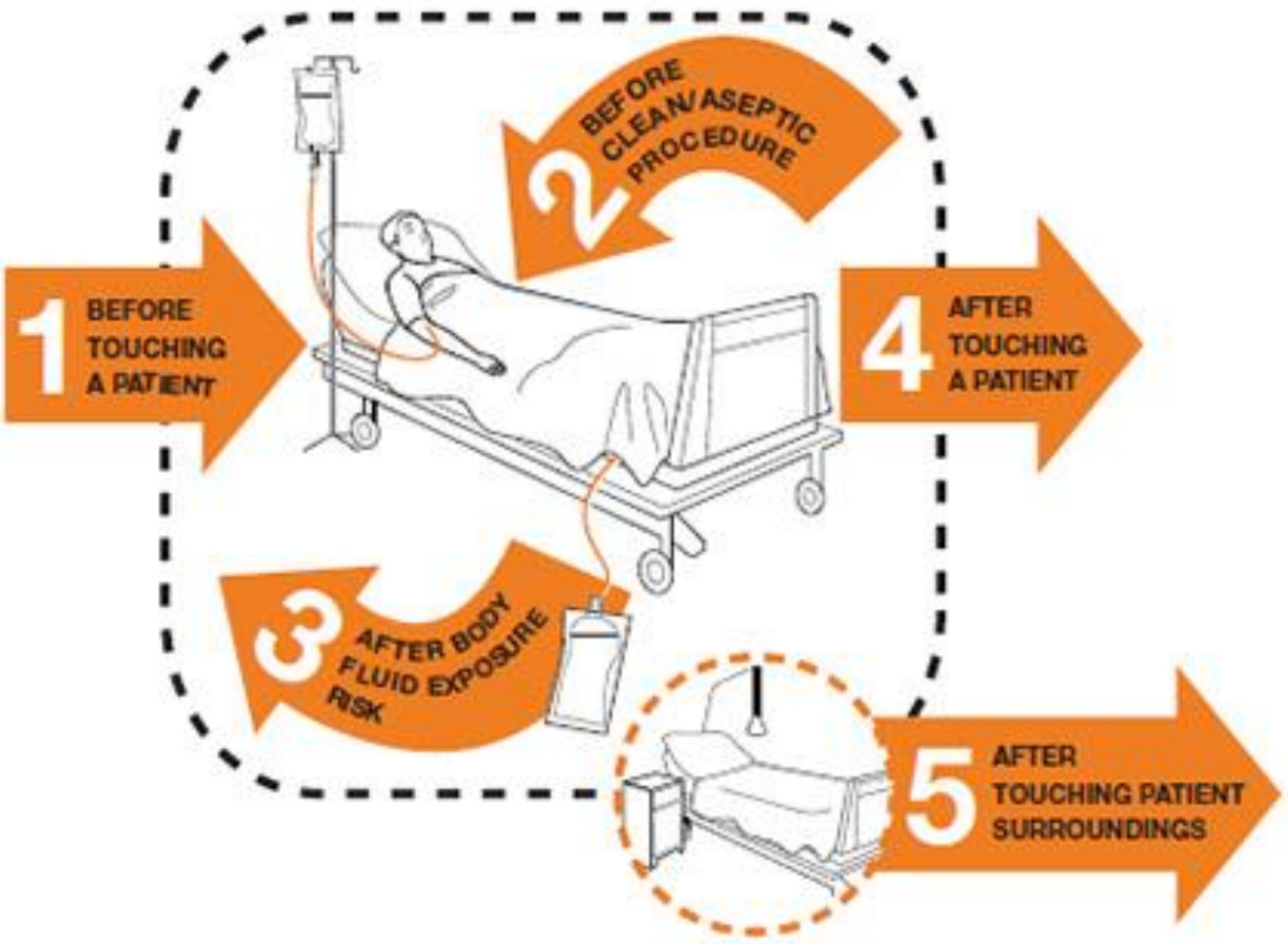


- SAFE HANDS… SAVES LIVES
- Hand Hygiene: An important role in reducing infections

❖ Health care associated infections are also called **Nosocomial infections**



My 5 Moments for Hand Hygiene



Standar Pencegahan









1. Cuci tangan yang benar
2. APD : Glove, mask, gown and googles
3. Penanganan peralatan pasien yang kotor
4. Lingkungan dan pembuangan limbah
5. Penanganan yang aman dari linen kotor
6. Penanganan yang aman dari benda tajam
7. Kebersihan pernafasan
8. Penanganan yang aman dari spesimen klinis
9. Pelaksanaan injeksi yang aman
10. Menggunakan masker untuk semua prosedur invasif



- Proses untuk Penilaian ulang pasien ketika ada indikasi perubahan pada kondisi, obat dll
- Jatuh adalah risiko serius terutama di antara pasien lanjut usia dan pasca operasi

Reduce the Risk of Patient Harm Resulting From Falls



- Identify fall-risk patients
- Screen all patients
- Assess ‘’at-risk’’ group and Re-Assess
- Prevent ‘’high-risk’’ patients from falls
- Educate patient and family
- Report falls and monitor trends-learn to prevent potential falls

[redacted]	NO. RM :
	NAMA PASIEN :
	TANGGAL LAHIR :

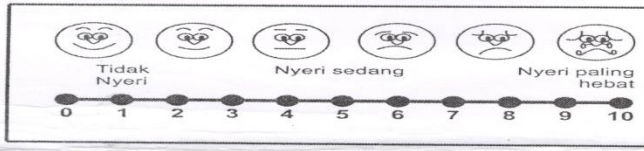
Morse Fall Risk Assesmen Ulang pada Pasien Dewasa

Faktor Resiko	Skala	Poin	Tanggal Asesmen Ulang				
Riwayat Jatuh	Ya	25					
	Tidak	0					
Diagnosis Sekunder (Ada 2 diagnosis medis)	Ya	15					
	Tidak	0					
Alat Bantu	Berpegangan pada perabot	30					
	Tongkat/ Alat penopang	15					
	Tidak ada/ kursi roda/ perawat/ tirah baring	0					
Terpasang Infus	Ya	20					
	Tidak	0					
Gaya Berjalan	Terganggu	20					
	Lemah	10					
	Normal/ tirah baring/ mobilisasi	0					
Status Mental	Sering lupa akan keterbatasan yang dimiliki	15					
	Sadar akan kemampuan diri sendiri	0					
Resiko tinggi ≥ 45, Resiko sedang = 25-44, Resiko rendah = 0-24		Total					
	NAMA & PARAF PETUGAS						

Humpty Dumpty Scale Asesmen Ulang pada Pasien Pediatri

	Kriteria	Poin	Tanggal Asesmen Ulang				
Umur	Di bawah 3 tahun	4					
	3 - 7 tahun	3					
	7- 13 tahun	2					
	>13 tahun	1					
Jenis Kelamin	Laki-Laki	2					
	Perempuan	1					
Diagnosa	Kelainan Neurologi	4					
	Perubahan dalam oksigenasi (Masalah Saluran Nafas, Dehidrasi, Anemia, Anoreksia, Sinkop / sakit kepala, dll)	3					
	Kelainan Psikis / Perilaku	2					
	Diagnosis lain	1					
Gangguan Kognitif	Tidak sadar terhadap keterbatasan	3					
	Lupa Keterbatasan	2					
	Mengetahui kemampuan diri	1					
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh dari tempat tidur saat bayi — anak	3					
	Pasien menggunakan alat bantu atau box atau mebel	2					
	Pasien berada di tempat tidur	1					
Respon terhadap Operasi/ Obat Penenang/Efek Anestesi	Di luar ruang gawat	4					
	Dalam 24 jam	3					
	Dalam 48 jam riwayat jatuh	2					
	> 48 jam	1					
Penggunaan Obat	Bermacam-macam obat yang digunakan : obat sedatif (kecuali pasien ICU yang menggunakan sedasi dan paralis), Hipnotik, Barbiturat, Fenotiazin, Anti depresan, Laksans / Diuretika, Narkotik	3					
	Salah satu dari pengobatan di atas	2					
	Pengobatan lain	1					
Resiko tinggi ≥ 12	TOTAL						
Resiko rendah = 7 - 11	Nama & Paraf yang melakukan penilaian						

ASESMEN ULANG SKALA NYERI



Shift	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
Pagi					
Siang					
Malam					

7 Langkah Keselamatan Pasien



Step 1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien



Step 2. Memimpin dan mendukung staf



Step 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko



Step 4 Mengembangkan sistem pelaporan

Step 5 Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien



Step 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien



Step 7. Mencegah cedera melalui implementasi system keselamatan pasien



BUILD THE SAFER SYSTEM !

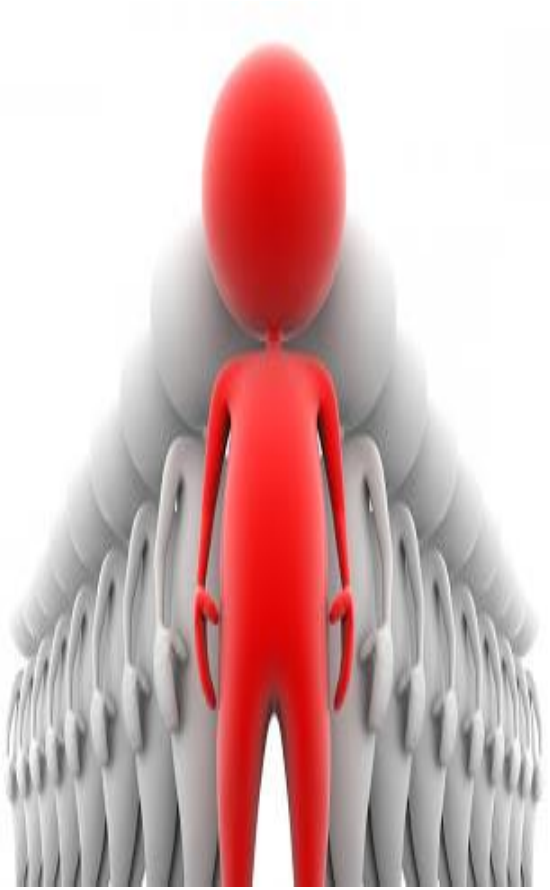
1. Membangun Kesadaran Akan Nilai Keselamatan Pasien

- Safety culture means:

1. Being open and fair
2. Having a systems approach to safety



2. Memimpin dan Mendukung staf



- Membangun fokus yang jelas dan kuat pada keselamatan pasien di seluruh organisasi Fasyankes

- Membangun keselamatan pasien ke dalam pelatihan untuk semua staf dan memastikan pelatihan ini dapat diakses dan diukur efektivitasnya

3. Mengintegrasikan Aktivitas Pengelolaan risiko



- Mengembangkan sistem dan proses untuk mengelola risiko, mengidentifikasi dan menilai hal-hal yang bisa salah
- Mengatur forum lokal untuk membahas manajemen risiko dan masalah keselamatan pasien serta memberikan umpan balik kepada kelompok manajemen yang relevan
- Menilai risiko untuk pasien individu saat mendapat pengobatan



- We need to be Proactive, not just reactive
- The proactive approach reduces the intensity of efforts invested in reactive actions

4. Mengembangkan Sistem Pelaporan



- Pastikan staf Anda dapat dengan mudah melaporkan insiden baik internal/eksternal
- 3 tipe insiden yang harus dilaporkan:

- Insiden yang sudah terjadi
- Insiden yang sudah dicegah
- Insiden yang mungkin
- Insiden yang mungkin terjadi

PENANGANAN INSIDEN

Pembentukan Tim KP→
Ditetapkan oleh pimpinan

Terdiri atas: unsur manajemen dan unsur klinisi di fasilitas pelayanan Kesehatan

Dilakukan kegiatan: Pelaporan, investigasi, dan analisis penyebab insiden

PELAPORAN INSIDEN

Waktu 2x24 jam menggunakan format laporan

Menentukan derajat insiden (grading) dan melakukan RCA

Bersifat rahasia

PELAPORAN INSIDEN

- Memuat:



Formulir 1

FORMULIR LAPORAN INSIDEN KE TIM KESELAMATAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Nama Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain .....

LAPORAN INSIDEN

(INTERNAL)

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 x 24 JAM

A. DATA PASIEN

Nama : .....

No MR : ..... Ruangan: .....

Umur : .... Bulan .... Tahun

Kelompok Umur* : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan - 1 tahun
☐ > 1 tahun - 5 tahun ☐ > 5 tahun - 15 tahun
☐ > 15 tahun - 30 tahun ☐ > 30 tahun - 65 tahun
☐ > 65 tahun

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Penanggung biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☐ Pemerintah ☐ Perusahaan*
☐ BPJS ☐ Lain-lain

Tanggal Masuk Rumah Sakit/ Pasyankes lain : ..... Jam : .....

B. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

   Tanggal : ..... Jam .....

2. Insiden : .....

3. Kronologis Insiden

   .....

   .....

   .....

4. Jenis Insiden* :

   ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)

   ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event) / Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*)

☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC

☐ KPC

5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden"

☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya

☐ Pasien

☐ Keluarga / Pendamping pasien

☐ Pengunjung

☐ Lain-lain ..... (sebutkan)

6. Insiden terjadi pada" :

☐ Pasien

☐ Lain-lain .....
(sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3 RS/unit K3 Fasyankes lain

7. Insiden menyangkut pasien :

☐ Pasien rawat inap ☐ Pasien rawat jalan

☐ Pasien UGD

☐ Lain-lain .....
(sebutkan)

8. Tempat Insiden

Lokasi kejadian ..... (sebutkan)
(Tempat pasien berada)

9. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)

☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya

☐ Anak dan Subspesialisasinya

☐ Bedah dan Subspesialisasinya

☐ Obstetri Ginekologi dan Subspesialisasinya

☐ THT dan Subspesialisasinya

☐ Mata dan Subspesialisasinya

☐ Saraf dan Subspesialisasinya

☐ Anastesi dan Subspesialisasinya

☐ Kulit dan Kelamin dan Subspesialisasinya

☐ Jantung dan Subspesialisasinya

☐ Paru dan Subspesialisasinya

☐ Jiwa dan Subspesialisasinya

☐ Lain-lain ..... (sebutkan)

10. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden

Unit kerja penyebab ..... (sebutkan)

11. Akibat Insiden Terhadap Pasien" :

☐ Kematian

- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ☐ Tidak ada cedera

12. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :

.....

.....

.....

13. Tindakan dilakukan oleh* :

- ☐ Tim : terdiri dari : .....
- ☐ Dokter
- ☐ Perawat
- ☐ Petugas lainnya .....

14. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

☐ Ya ☐ Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....

.....

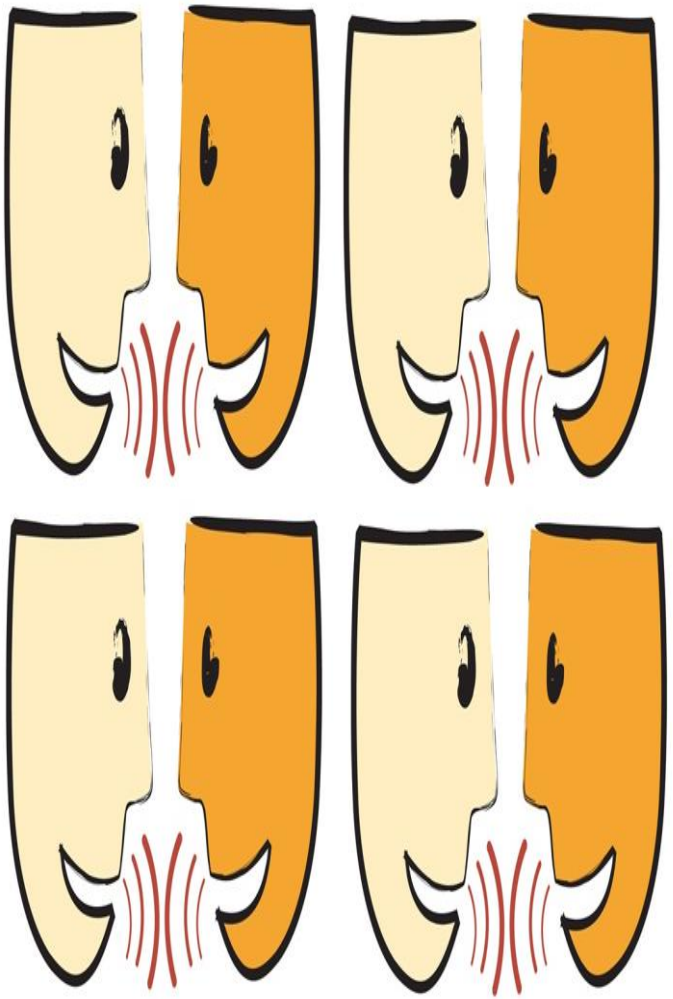
Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	: .....
Paraf	:	Paraf	: .....
Tgl Terima	:	Tgl Lapor	: .....

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU HIJAU KUNING MERAH

NB. * = pilih satu jawaban.

5. Melibatkan dan Berkomunikasi dengan Pasien



- Mengembangkan cara untuk berkomunikasi secara terbuka dengan mendengarkan pasien
- Prioritaskan kebutuhan untuk memberitahu pasien dan keluarganya ketika insiden terjadi dan menyediakan informasi yang jelas, tepat dan akurat

6. Belajar dan Berbagi Pengalaman tentang Keselamatan Pasien



- Mendorong staf untuk menggunakan analisis akar penyebab masalah untuk mempelajari bagaimana dan mengapa insiden terjadi
- Ketika insiden keselamatan pasien terjadi, isu penting tidak menyalahkan atas insiden tersebut tapi bagaimana dan mengapa hal itu terjadi

7. Mencegah Cedera Melalui Implementasi Sistem Keselamatan Pasien



- Penanamkan pelayanan melalui perubahan untuk berlatih
- Libatkan tim dalam mengembangkan cara untuk membuat perawatan px lebih baik dan aman
- Pastikan tim anda menerima umpan balik pada setiap tindak lanjut insiden yang dilaporkan



Laporan Insiden

Patient Safety Starts with me!



DAFTAR PUSTAKA

- PERMENKES No. 11 Tahun 2017
- JCI Accreditation Standard for Hospital, 4th edition, 2011
- Medical Mishaps: A Managerial Perspective, Liam J. Donaldson, in Medical Mishaps, Pieces of the Puzzle, Open University Press Buckingham-Philadelphia, 1999
- Patient Safety, 2nd Edition, by Charles Vincent, Published 2010 by Blackwell Publishing Ltd
- The Essential of Patient Safety, by Charles Vincent, 2011
- World Alliance for Patient Safety, Forward Programmed, WHO, 2004


Thank
You